

北京安贞医院诊断报告

【患者信息】

姓名	赵明德	性别	男
年龄	64岁	住院号	2025AZ0117
入院日期	2024年12月15日 14:30	出院日期	2024年12月22日 09:00
科室	心内科三病区	床位号	38床

【主诉】

反复发作性胸痛半月，加重3天。患者于半月前无明显诱因出现胸骨后压榨样疼痛，向左侧肩部放射，每次持续约5-10分钟，休息或含服硝酸甘油后缓解，每日发作约2-3次。近3天来胸痛发作频率增加，每日约5-6次，且轻微活动即可诱发，伴出汗、心悸。

【体格检查】

T 36.5°C, P 78次/分, R 18次/分, BP 150/95mmHg。神志清楚，口唇无发绀。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。心率78次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

【辅助检查】

心电图（2024-12-15）：窦性心律，V1-V4导联ST段水平型压低0.1-0.2mV，T波倒置，提示前壁心肌缺血。

动态心电图：24小时共监测到ST段压低发作12次，其中5次伴有胸痛症状，最长持续时间15分钟。

心脏彩超：左心室舒张末期内径52mm，室间隔厚度11mm，左室后壁厚度11mm，射血分数（LVEF）58%，二尖瓣轻度关闭不全，左室舒张功能减低。

冠状动脉CTA：左前降支（LAD）近段管壁可见软硬斑块，管腔狭窄约70%-80%；左旋支（LCX）中段狭窄约40%；右冠状动脉（RCA）未见明显狭窄。

实验室检查：CK-MB 5.2 ng/mL (0-4.3)，hs-cTnI 120 pg/mL (<26)，提示微量心肌损伤。

【诊断】

主要诊断：

1. 冠心病 (I20.0)

不稳定型心绞痛

- 冠状动脉粥样硬化性心脏病，前降支重度狭窄（70%-80%）

- 心功能II级（NYHA分级）

次要诊断：

2. 高血压病3级（极高危组） (I10)

3. 高脂血症 (E78.5)

【治疗方案】

一、药物治疗：

1. 阿司匹林肠溶片 100mg/次，口服，每日1次（早餐后），长期服用。

2. 硫酸氢氯吡格雷片（波立维）75mg/次，口服，每日1次，至少服用12个月。

3. 阿托伐他汀钙片（立普妥）40mg/次，口服，每日1次（睡前），控制血脂。

4. 琥珀酸美托洛尔缓释片（倍他乐克）47.5mg/次，口服，每日1次，控制心率。

5. 苯磺酸氨氯地平片（络活喜）5mg/次，口服，每日1次，控制血压。

6. 硝酸异山梨酯片（消心痛）10mg/次，口服，每日3次，预防心绞痛发作。

二、介入治疗建议：

建议择期行冠状动脉造影及前降支支架植入术（PCI），以完全再血管化。

【出院医嘱】

1. 遵医嘱坚持药物治疗，不可擅自停药或调整剂量。服用抗血小板药物期间注意有无牙龈出血、皮肤瘀斑、黑便等出血倾向，如有异常及时就诊。
2. 低盐低脂饮食（每日食盐摄入量<5g），戒烟，限制饮酒，控制体重（BMI控制在24以内）。
3. 适度有氧运动（步行、太极等），每次30分钟，每周至少5天，避免剧烈运动和情绪激动。
4. 控制心血管危险因素：血压目标<130/80 mmHg，LDL-C目标<1.8 mmol/L，空腹血糖<6.1 mmol/L。
5. 出院后1周门诊复查心电图、血常规、肝肾功能、血脂、CK。择期住院行冠脉造影。
6. 如出现胸痛持续不缓解（>20分钟）、伴有大汗、呼吸困难等症状，立即拨打120就诊。

主治医师：李国栋（主任医师）

科室：心血管内科三病区

日期：2024年12月22日